ESE Hospital Sintético San Jerónimo

Código de habilitación 230010999903 · HISTORIA CLÍNICA DE HOSPITALIZACIÓN

DATOS DEL PACIENTE

USUARIO: ANDRES JORGE OSORIO SALAZAR DOCUMENTO: CC 45608499 EDAD: 63 años SEXO: MASCULINO

FECHA DE NACIMIENTO: 25-05-1963 PROCEDENCIA: Montelíbano DIRECCIÓN: Diagonal 56 # 36-61

TELÉFONO: 316 618 6434 ASEGURADORA: Mutual Ser HISTORIA: HC-2026-7252 EPISODIO: ADM-323216

FECHA DE INGRESO: 19-08-2026 12:05 SERVICIO: HOSPITALIZACIÓN

MOTIVO DE CONSULTA

«Dolor fuerte en la barriga del lado derecho».

ENFERMEDAD ACTUAL

Dolor en hipocondrio derecho de 24 horas, intensidad 8/10, irradiado a la espalda, con vómito en tres ocasiones y fiebre subjetiva. Intolerancia a grasas de larga data.

Según refiere su familiar Alvaro Leidy Reyes Jaramillo, el cuadro empeoró en las últimas horas.

ANTECEDENTES

Personales: colelitiasis conocida hace dos años. Familiares: sin relevancia. Alérgicos: niega.

EXAMEN FÍSICO

TA 132/86 mmHg, FC 102 lpm, FR 20 rpm, T 38,4 °C. Signo de Murphy positivo, sin signos de irritación peritoneal generalizada.

ANÁLISIS

Colecistitis aguda litiásica; se hospitaliza para manejo quirúrgico.

DIAGNÓSTICOS

- K810 Colecistitis aguda
- K802 Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis

ÓRDENES

- Ecografía hepatobiliar. Justificación: Dolor en hipocondrio derecho con Murphy positivo.
- Hemograma, bilirrubinas, transaminasas. Justificación: Evaluar respuesta inflamatoria y descartar colestasis.
- Colecistectomía laparoscópica. Justificación: Colecistitis aguda litiásica confirmada por ecografía.

RESULTADOS

- Ecografía hepatobiliar: vesícula distendida, pared de 6 mm, cálculo de 18 mm en el cuello. Interpretación: Confirma colecistitis aguda litiásica.
- Hemograma: leucocitos 14.800. Interpretación: Respuesta inflamatoria.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

El paciente o su representante recibe información sobre el procedimiento Colecistectomía laparoscópica bajo anestesia general, sus riesgos y alternativas, y firma el consentimiento, que se anexa a la historia.

PLAN DE MANEJO

- Nada vía oral.
- Lactato de Ringer 1.000 mL intravenoso cada 8 horas.
- Ampicilina sulbactam 3 g intravenoso cada 6 horas.

- Colecistectomía laparoscópica.

EVOLUCIÓN

20-08-2026 10:21 · Día 2: Colecistectomía laparoscópica sin complicaciones, sangrado de 30 mL. Tolera vía oral líquida.

21-08-2026 19:07 · Día 3: Dolor controlado, deambula, heridas limpias.

EPICRISIS

22-08-2026 · Día 3: Egreso. Diagnóstico de egreso: colecistitis aguda litiásica, posoperatorio de colecistectomía laparoscópica. Plan: acetaminofén 1 g cada 8 horas por 5 días, curación de heridas, control en 8 días con patología.

PROFESIONAL

Atendido por: David Katherine Burgos Burgos. Registro médico: RM-63700. Especialidad: Ginecología. Firma: _____

Fecha y hora de la anotación: 19-08-2026 12:05